

|                                                                                                               |                                                                           |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br>Intensivpflege-Halle-GmbH | <b>Verfahrensanleitung</b><br><b>„Stellen von</b><br><b>Medikamenten“</b> | Qualitätshandbuch                   |
|                                                                                                               |                                                                           | Geltungsbereich:<br>Pflegefachkraft |

## 1. Ziel und Zweck:

- Jeder Patient erhält die für ihn vorgesehenen Medikamente. Die "6-R-Regel" wird genau befolgt.
- Alle hygienischen Vorschriften werden genau beachtet.
- Wir verschwenden keine Medikamente.
- Die kontinuierliche Versorgung des Patienten ist gesichert. Es gibt keine Versorgungsengpässe.

## 2. Anwendungsbereich:

Viele Patienten haben ein Selbstversorgungsdefizit im Bereich der Medikamenteneinnahme. Vor allem zwei Problemschwerpunkte treten gehäuft auf:

- Beim Fortschreiten einer demenziellen Erkrankung sind viele Betroffene damit überfordert, die Arzneimittel regelmäßig einzunehmen. So kann es vorkommen, dass die Einnahme vergessen wird oder versehentlich doppelt erfolgt.
- Andere Senioren sind in ihrer Feinmotorik so weit eingeschränkt, dass sie z. B. keine Tabletten aus der Verblisterung herausdrücken können.
- Derartige Defizite werden kompensiert, indem wir die Medikamente für den Patienten stellen und falls nötig die Einnahme überwachen.

## 3. Durchführung und Zuständigkeiten:

### Organisatorisches

- Die Pflegekraft sorgt für ausreichend Freifläche und geeignete Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz.
- Tropfen werden maximal eine Stunde vor der Verabreichung gestellt.
- Es sollte ein Zeitpunkt im Tagesverlauf gewählt werden, der erfahrungsgemäß vergleichsweise ruhig ist.
- Am besten sollten die Medikamente von der Pflegekraft gerichtet werden, die diese auch an den Patient ausgibt. Wenn die ausgebende Pflegekraft die Arzneimittel nicht eigenhändig vorbereitet hat, muss sie sich davon überzeugen, dass die Medikamente richtig gestellt wurden. Dieses ist auch erforderlich, wenn die Arzneimittel, von einer Apotheke, verblistert wurden.
- Die Pflegekraft stellt sicher, dass der Medikamentendispenser korrekt beschriftet ist, also mit dem Vornamen und dem Nachnamen
- Die Pflegekraft muss die Wirkungsweise sowie die wichtigsten Neben- und Wechselwirkungen aller, von ihnen verarbeiteten Medikamenten, kennen. Bei Fragen liest sie den Beipackzettel.
- Medikamente, die in einem Peel-off-Blister (zum Abziehen) stecken oder feuchtigkeitsanfällig sind, sollten erst kurz vor der Einnahme aus dem Blister entnommen werden. Sie dürfen nicht auf Vorrat entblistert werden.

| Freigabe | Bearbeiter | Datum      | Änderung | Version | Seite | Verteiler |
|----------|------------|------------|----------|---------|-------|-----------|
| GF       | PDL/QMB    | 17.01.2023 |          | 001     | 1     | Verw./MA  |

|                                                                                                                      |                                                                           |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>Intensivpflege-Halle-GmbH</b> | <b>Verfahrensanleitung</b><br><b>„Stellen von</b><br><b>Medikamenten“</b> | Qualitätshandbuch                   |
|                                                                                                                      |                                                                           | Geltungsbereich:<br>Pflegefachkraft |

### Kontrolle:

- Beim Umgang mit Medikamenten gilt das Prinzip der dreifachen Kontrolle. Geprüft wird:
  - bei der Entnahme des Arzneimittels aus dem Medikamentenschrank oder aus dem Vorratsbehälter
  - bei der Entnahme aus der Originalverpackung
  - beim Zurückstellen in den Medikamentenschrank.
- Grundlage des Medikamentenstellens ist ausschließlich das ärztliche Dokumentationsblatt. Die ärztliche Verordnung sollte nicht auf andere Formulare übertragen werden, um Übertragungsfehler zu vermeiden. Insbesondere führen wir keine "Tropfenpläne". Zudem ist beim ärztlichen Dokumentationsblatt eine saubere Handschrift besonders wichtig. Eintragungen, die nicht eindeutig lesbar sind, dürfen nicht ausgeführt werden.
- Im Zweifel sollte die Pflegekraft die Medikation stets kritisch hinterfragen. Ihr muss bewusst sein, dass auch Ärzte Fehler machen. Bei einer ganz offensichtlich fragwürdigen Verordnung muss die Pflegekraft Rücksprache mit dem behandelnden Arzt halten. Diese Rücksprache wird dokumentiert und ggf. wird der Arzt aufgefordert unsere Bedenken zu quittieren
- Bevor die Pflegekraft die Einzeldosen entnimmt und in den Behältnissen für den jeweiligen Patient ablegt, prüft sie, ob der Name und der Vorname des Patienten auf dem Medikamentendispenser bzw. Medikamententablett mit den Daten auf dem Verordnungsblatt übereinstimmen.
- Anschließend stellt sie sicher, dass die Angaben auf der Arzneimittelverpackung mit der Verordnung hinsichtlich des Medikamentennamens, der Dosis, der Arzneiform sowie der Applikationsart übereinstimmen.
- Die "6-R-Regel" wird beim Stellen der Medikamente strikt beachtet. Also:
  - Richtiger Patient. Besondere Vorsicht ist notwendig bei häufig vorkommenden Namen wie Maier oder Müller.
  - Richtiges Medikament. Völlig unterschiedliche Medikamente können ähnlich klingende Namen haben. Auch die Größe, die Farbe und das Schriftbild können ähnlich wirken.
  - Richtige Dosierung. Ein Präparat kann in unterschiedlichen Dosierungen und Konzentrationen verkauft werden.
  - Richtige Applikationsform. Das gleiche Medikament und der gleiche Wirkstoff können in unterschiedlichen Darreichungsformen verfügbar sein, also etwa als Saft, als Tabletten oder in Ampullen.
  - Richtige Zeit. Neben der Tageszeit können auch zeitliche Abstände zu anderen Medikamenten oder Ereignissen definiert werden; also etwa der richtige Spritz-Ess-Abstand bei Insulin.
  - Richtige Dokumentation. Die Verordnungsangaben müssen korrekt übertragen werden
- Vor der Verarbeitung stellt die Pflegekraft sicher, dass das Medikament intakt ist. Kriterien:
  - Das Verfallsdatum ist noch nicht erreicht.
  - Die Schutzverpackung (etwa Blister) ist unversehrt.
  - Die Medikamentenverpackung ist trocken und zeigt keine Flecken.
  - Es gibt keine Form- oder Farbveränderungen.

| Freigabe | Bearbeiter | Datum      | Änderung | Version | Seite | Verteiler |
|----------|------------|------------|----------|---------|-------|-----------|
| GF       | PDL/QMB    | 17.01.2023 |          | 001     | 2     | Verw./MA  |



- Bei Flüssigkeiten sind keine untypischen Ausflockungen, Trübungen, Geruchsveränderungen usw. bemerkbar.
- Wenn die Arzneimittel hinsichtlich ihres Aussehens, ihres Geruchs oder ihrer Beschaffenheit verändert sind, werden diese nicht verabreicht. Im Zweifelsfall setzen wir uns mit der Apotheke in Verbindung.

Weiter zu beachten:

- Die Verordnungsdaten müssen dem Medikamentenblatt zweifelsfrei zu entnehmen sein. Falls Fragen offenbleiben, bricht die Pflegekraft das Stellen ab und hält Rücksprache mit dem Arzt. Die Mindestkriterien für eine korrekte Verschreibung umfassen:
  - Name und Vorname des Patienten
  - Bezeichnung des Medikaments
  - Arzneiform, etwa "Tablette"
  - Applikationsintervall, etwa "dreimal täglich"
  - Dosierung in 24 Stunden, etwa "60 mg"
  - Applikationsart, etwa "per os"
  - ggf. Befristung der Medikamentengabe.
- Sofern dieses von der Apotheke noch nicht getan wurde, vermerkt die Pflegekraft alle wichtigen Informationen auf der Medikamentenverpackung. Etwa:
  - Lieferdatum
  - Anbruch Datum
  - Name des Patient
- Es kann vorkommen, dass der Patient ein anderes Präparat bekommt. Dieses etwa, weil er nun ein preisgünstigeres Generikum einnehmen soll. Wir stellen dann sicher, dass der Patient über diesen Wechsel informiert wird. Generika sind im Verordnungsplan zu dokumentieren.
- Dragees dürfen zumeist nicht zerteilt werden, da an den Bruchstellen der ggf. magensaftresistente Film fehlt.
- Flüssige Medikamente sollten grundsätzlich nicht miteinander vermischt werden, da es zu unvorhersehbaren chemischen Reaktionen kommen kann.
- Manche Medikamente brauchen einen strikten Schutz vor Licht und eignen sich daher nicht für ein Stellen mit langem Vorlauf.

Hygiene:

- Vor dem Stellen der Medikamente säubert und desinfiziert die Pflegekraft den Arbeitsplatz.
- Die Pflegekraft stellt sicher, dass die Medikamentenschälchen bzw. Medikamentendispenser hygienisch einwandfrei sind.
- Die Pflegekraft wäscht sich vor dem Richten der Arzneimittel stets die Hände und führt eine hygienische Händedesinfektion durch.
- Ggf. sollte die Pflegekraft Einmalhandschuhe tragen oder eine desinfizierte Pinzette bereitlegen.
- Bei Durchdrückpackungen werden die Arzneimittel direkt in den Medikamentenbecher gedrückt. Ein Kontakt mit der Hand ist zu vermeiden. Falls notwendig, kann eine Pinzette genutzt werden, um die Arzneimittel zu entnehmen. Ein Handkontakt kann das Medikament kontaminieren. Zudem könnte ein kleiner Teil des Wirkstoffs über die Haut aufgenommen werden. Dieses könnte bei der Pflegekraft etwa allergische Reaktionen auslösen.

| Freigabe | Bearbeiter | Datum      | Änderung | Version | Seite | Verteiler |
|----------|------------|------------|----------|---------|-------|-----------|
| GF       | PDL/QMB    | 17.01.2023 |          | 001     | 3     | Verw./MA  |

|                                                                                                                     |                                                                           |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>Intensivpflege-Halle-Gmb</b> | <b>Verfahrensanleitung</b><br><b>„Stellen von</b><br><b>Medikamenten“</b> | Qualitätshandbuch                   |
|                                                                                                                     |                                                                           | Geltungsbereich:<br>Pflegefachkraft |

- Wenn Medikamente auf den Boden fallen oder auf andere Weise potenziell kontaminiert wurden, werden sie in einem geeigneten Behälter entsorgt.
- Bei der Zubereitung von Saft oder von Sirup muss der patientenbezogene Messlöffel als Dosierlöffel genutzt werden.

#### Nachbereitung:

- Der Arbeitsplatz wird aufgeräumt.
- Das verwendete Material wird ggf. sicher entsorgt.
- Verschmutzte oder verklebte Originalverpackungen werden vor dem Zurückstellen in den Medikamentenschrank gereinigt oder ggf. verworfen. Ein Keimwachstum muss vermieden werden.
- Wenn Medikamente während des Stellens kontaminiert oder zerstört wurden, sollte dieses schriftlich vermerkt werden. Insbesondere bei Opioiden ist es sinnvoll, die Namen von etwaigen Zeugen zu notieren, um späteren Vorwürfen entgegentreten zu können.
- Beschädigte oder verunreinigte Medikamente werden im dafür vorgesehenen Abwurfbehälter entsorgt. Bis zur Rückgabe an die Apotheke muss sichergestellt werden, dass kein Unbefugter Zugriff auf diese Arzneimittel hat.
- Die Arzneimittel werden stets an den gleichen Platz im Schrank gestellt, von dem sie entnommen wurden.
- Fehlende oder in kurzer Zeit ausgehende Medikamente werden frühzeitig nachbestellt.
- Nach dem Richten der Medikamente oder bei unerwarteten Arbeitsunterbrechungen wird das Tablett sicher gelagert. Bis zum Verteilen darf kein Unbefugter Zugriff erhalten. Der Schrank und der Arbeitsraum werden also ggf. abgeschlossen. Zudem müssen die gestellten Medikamente vor Staub, vor Feuchtigkeit, vor Licht und vor Wärme geschützt werden.
- Die gesamte Maßnahme wird sorgfältig dokumentiert.
- Auftretende Probleme beim Stellen von Medikamenten werden im Qualitätszirkel diskutiert.

#### Qualifikation/Durchführungsverantwortung:

- Pflegefachkräfte

#### Prozessverantwortlichkeit:

- Pflegedienstleitung, stellv. PDL, Teamleitung

| Freigabe | Bearbeiter | Datum      | Änderung | Version | Seite | Verteiler |
|----------|------------|------------|----------|---------|-------|-----------|
| GF       | PDL/QMB    | 17.01.2023 |          | 001     | 4     | Verw./MA  |